Consideraciones generales sobre el tratamiento intervencionista del dolor

Tratamiento intervencionista del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Situación actual del intervencionismo para dolor crónico en el entorno
4. Evaluación del paciente candidato a técnica intervencionista para dolor crónico
5. Indicaciones de procedimientos invasivos en dolor crónico no oncológico
6. Indicaciones de procedimientos invasivos en dolor oncológico
7. Bibliografía

Objetivos

- Mostrar al alumno el estado actual del intervencionismo en el ámbito sanitario.
- Conocer las indicaciones generales de asistencia en unidades de dolor especializadas.
- Conocer los criterios de selección de los pacientes candidatos a técnicas intervencionistas.
- Dar a conocer los criterios de admisión en unidades de dolor específicos en síndrome dolorosos concretos como el dolor neuropático o el dolor oncológico.

Introducción

Aunque el uso de analgésicos opioides es considerada una herramienta eficaz para el tratamiento del dolor crónico, en la actualidad existe un fuerte impulso hacia alternativas no opioides desde los inicios de la crisis de opiáceos, con 15.000 muertes relacionadas con la prescripción, el abuso y dependencia a los mismos, de 2 millones de estadounidenses en 2015.

De acuerdo con estimaciones recientes, hasta un 37% de la población en países desarrollados se encuentra afectada por dolor crónico, siendo el dolor lumbar crónico el más común.

Así pues, el tratamiento intervencionista en pacientes con dolor crónico ha experimentado en las últimas décadas cambios muy significativos a raíz de la aplicación de nuevas técnicas mínimamente invasivas.

El desarrollo de nuevas tecnologías e instrumentos quirúrgicos precisos, así como el empleo de equipos de imagen con mayor resolución, ha originado que se pueda acceder de forma segura a objetivos de difícil acceso donde alterar su estructura o modular la transmisión dolorosa *(Figura 1).*

Figura 1. Sala de técnicas intervencionistas. Unidad para el tratamiento del dolor crónico.

Situación actual del intervencionismo para dolor crónico en el entorno

En décadas anteriores, el tratamiento inicial del dolor crónico estaba basado fundamentalmente en la administración de fármacos y sólo de manera ocasional eran utilizadas técnicas de forma complementarias, posicionando al intervencionismo para dolor en el último escalón de la escalera analgésica.

Actualmente, es bien sabido que ambos tratamientos (tanto farmacológico como intervencionista) son fundamentales para conseguir un control óptimo del dolor.

El tratamiento intervencionista del dolor crónico ha avanzado mucho en los últimos años, especialmente con la aplicación de las nuevas tecnologías de neuromodulación y sus diferentes modalidades, mostrando gran eficacia en pacientes con dolor neuropático crónico.

En la actualidad, el especialista en tratamiento del dolor debe tener una extensa formación para saber utilizar todas las herramientas terapéuticas que tiene en sus manos, no sólo farmacológicas, sino también intervencionistas. La tendencia actual en el entorno es no posponer dicho intervencionismo, pues se tienen técnicas que, utilizadas de forma precoz, pueden ser beneficiosas para el paciente, pudiendo alcanzar la reducción de la dosis y efectos secundarios de su tratamiento farmacológico, consiguiendo, en alguna ocasión, la resolución del cuadro. Para asegurarse un buen resultado con la intervención, es imprescindible una correcta selección del paciente que se va a beneficiar de la técnica.

Por todo ello, la cartera de servicio de las unidades de dolor, publicadas en los diferentes planes regionales del país, es cada vez más intervencionistas.

Evaluación del paciente candidato a técnica intervencionista para dolor crónico

Las modalidades de tratamiento intervencionista del dolor crónico requieren una selección idónea de pacientes desde un enfoque multidisciplinar en el que no sólo hay que evaluar la naturaleza del dolor, sino también valorar los factores psicológicos que puedan generarlo y mantenerlo.

Esta selección de pacientes basada en este enfoque multidisciplinar se correlaciona con el éxito y el fracaso de la técnica, aunque no existe un consenso claramente establecido que garantice el éxito de la intervención.

De forma generalizada, se consideran candidatos a la realización de una técnica intervencionista para dolor aquellos pacientes que:

- No han obtenido mejoría con tratamiento con opioides.
- No han conseguido mejoría funcional a pesar del tratamiento farmacológico prescrito.
- Presentan dolor neuropático de difícil control.
- Presentan ausencia de diagnóstico satisfactorio.
- Tienen antecedentes de mal uso de la medicación.
- Tienen componente psicosocial negativo importante.

Se recomienda explicar al paciente el tipo de dolor que padece, exponiendo las opciones de tratamiento basadas en la evidencia de manejo del dolor a largo plazo.

Las técnicas intervencionistas realizadas en una Unidad del Dolor deben presentarse como una forma integral de abordaje, evitando que el paciente suponga que es la última posibilidad terapéutica, por la desesperanza o sensación de abandono que puede significar.

No debe demorarse la derivación para realización de intervencionismo para dolor, ya que se esperan superiores de seis meses desde dicha derivación, y se han asociado a un deterioro en la calidad de vida relacionado con un aumento de los síntomas depresivos.

Los criterios de admisión en Unidad de Tratamiento del Dolor son los siguientes:

- Síndrome doloroso persistente, experiencia dolorosa que se prolonga más allá del de la curación de la lesión inicial (fase crónica, más de tres meses de duración).
- Falta de respuesta terapéutica cuando se utilizan intervenciones o tratamientos adecuados enfocados desde el modelo biomédico.

La colaboración de una Unidad del Dolor, tanto con atención primaria como con el resto de especialidades, es fundamental para una buena selección de aquel paciente candidato a técnica intervencionista para tratamiento del dolor *(Figura 2).*

Figura 2. Quirófano de técnicas intervencionistas para dolor

Indicaciones de procedimientos invasivos en dolor crónico no oncológico

Como se ha mencionado con anterioridad, el tratamiento del dolor crónico ha avanzado mucho los últimos años, especialmente con la aplicación de las nuevas tecnologías de neuromodulación y sus diferentes modalidades, mostrando gran eficacia en pacientes con dolor neuropático crónico, como el síndrome regional complejo y el síndrome de cirugía fallida de espalda lumbar o cervical.

Según recomendaciones basadas en la evidencia, un paciente con dolor neuropático debe remitirse a un servicio especializado para realización de intervencionismo específico de la condición subyacente en cualquier etapa, incluso en la presentación inicial y en los controles, si presenta cualquiera de los siguientes criterios de derivación a Unidad del Dolor para intervencionismo específico de dolor neuropático:

- Dolor intenso o que limita significativamente la calidad de vida (incluyendo trastornos del sueño y el ánimo).
- Deterioro de la condición de salud subyacente.
- Comorbilidades médicas complejas: tanto cardiovasculares, renales y metabólicas que dificulten el tratamiento farmacológico.
- Diagnóstico no claro: sin elementos neuropáticos categóricos o con elementos agregados que sugieran otra patología.
- Alto potencial de abuso de sustancias derivadas de opioides.
- Polifarmacia.
- Refractariedad a múltiples terapias de dolor, tanto farmacológicas como no farmacológicas.

Es fundamental considerar al paciente desde un enfoque biopsicosocial, determinando también su potencial capacidad de respuesta al intervencionismo, como en el caso del implante de un neuroestimulador medular, valorando posibles expectativas y creencias asociadas al dolor y a la terapia, comorbilidades y respuestas afectivas que puedan modular la intensidad o frecuencia del dolor.

La evidencia científica refiere que, para obtener un buen resultado de la técnica, es importante la selección idónea de pacientes y un dominio absoluto de la técnica.

Indicaciones de procedimientos invasivos en dolor oncológico

El dolor oncológico es un problema presente en aproximadamente el 50% de los pacientes con cáncer, llegando al 75% en el caso de estadios avanzados de la enfermedad, por tanto, es el síntoma más frecuente y temido en la población oncológica.

En un porcentaje no desdeñable de pacientes no se consigue alcanzar el control del mismo, a pesar de la terapia farmacológica de segundo y tercer escalón.

Por todo lo anterior, se sugieren terapias combinadas que incluyan intervencionismo cuando este sea preciso en función de las características individuales de cada paciente y con el fin de optimizar la reducción del dolor con los mínimos efectos secundarios posibles. La precocidad en la aplicación de los procedimientos intervencionistas en el paciente oncológico es algo en lo que no existe un consenso adecuado.

El dolor oncológico presenta características complejas, siendo, en muchas ocasiones, muy difícil de tratar con un perfil mixto y con componente neuropático (por invasión de las meninges, médula espinal o duramadre, raíces nerviosas, plexos nerviosos y nervios periféricos). Especialmente en estos casos es necesario un enfoque multimodal y la aplicación precoz de métodos intervencionistas *(Figura 3).*

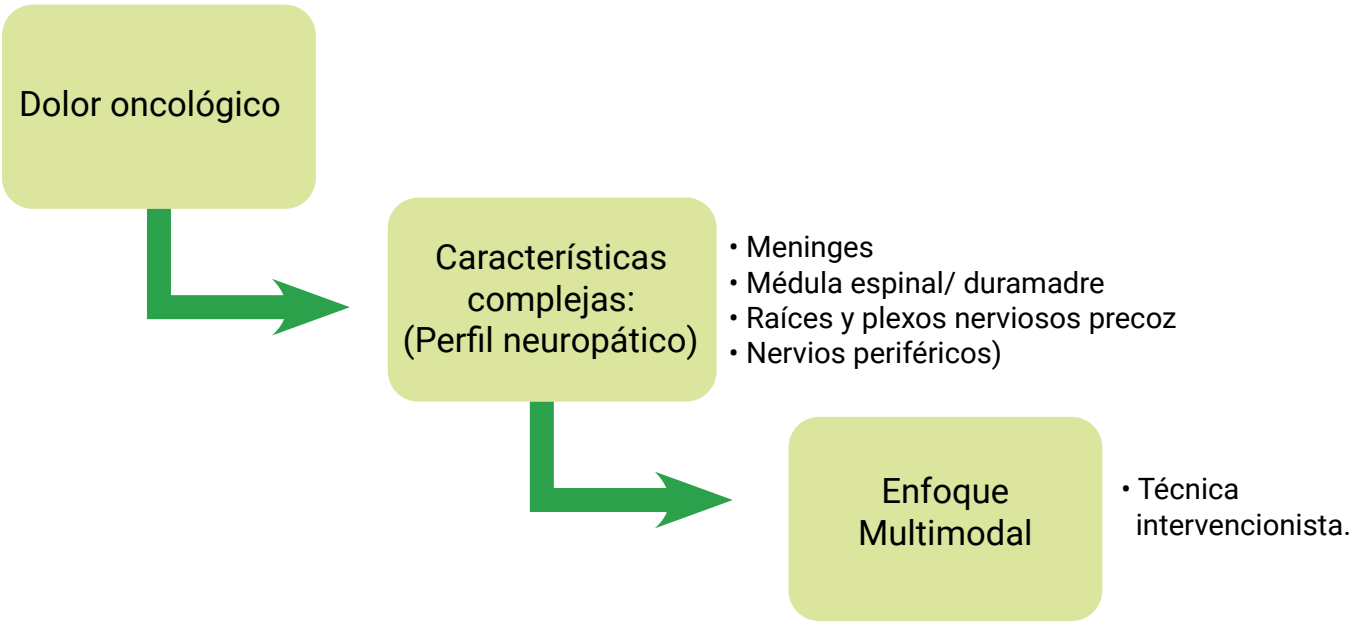

Figura 3. Intervencionismo en dolor oncológico.

Bibliografía

1. Dougherty M.C., Woodroffe R.W., Wilson S., Gilles G.T., Howard M.A., Carnahan R.M. 2019. Predictors of Reduced Opioid Use With Spinal Cord Stimulation in Patients With Chronic Opioid Use. Neuromodulation 2019; E-pub ahead of print. DOI:10.1111/ner.13054
2. Spinal Cord Stimulation Systems and Implantation. https://www.aans.org/.
3. Frey ME, Manchikanti L, Benyamin RM, Schultz DM, Smith HS, Cohen SP. Spinal cord stimulation for patients with failed back surgery syndrome: a systematic review. Pain Physician 2009;12:379–397.
4. Tsang A, Von Korff M, Lee S et al. Common chronic pain conditions in developed and developing countries: gender and age differences and comorbidity with depression-anxiety disorders. J Pain. 2008;9:883–891.
5. Volkow ND, Thomas McLellan A. Opioid abuse in chronic pain—misconceptions and mitigation strategies. N Engl J Med 2016;374:1253–1263. https://doi.org/10. 1056/nejmra1507771.
6. Sección técnicas intervencionistas en tratamiento del dolor: Revista Sociedad Española de Dolor. Rev. Soc. Esp. Dolor [online]. 2011, vol.18, n.1 [citado 2020-04-09], pp.64-64. <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462011000100009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1134-8046.
7. Gallach E, Canos A, Morales M, Protocolo psicológico para la evaluación de candidatos a implante de neuroestimulador. Rev Soc Esp Dolor 2016; 23(6): 307-315
8. Rincón AM, Olaya CA, Martínez S, Bernal I. Recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo del dolor neuropático (revisión de la literatura). Rev Soc Esp Dolor 2018; 25(6): 349-358. DOI: 10.20986/resed.2018.3673/2018.
9. Palanca Sánchez I (Dir.), Puig Riera de Conías MM (Coord. Cient.), Elola Somoza J (Dir.), Bernal Sobrino JL (Comit. Redac.), Paniagua Caparrós JL (Comit. Redac.), Grupo de Expertos. Unidad de tratamiento de dolor: estándares y recomendaciones. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011.
10. van den Beuken-van Everdingen MH, de Rijke JM, Kessels AG, Schouten HC, van Kleef M, Patijn J. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol 2007;18:1437–1449.
11. Meuser T, Pietruck C, Radbruch L, et al. Symptoms during cancer pain tre atment following WHO guidelines: a longitudinal follow-up study of symptom prevalence, severity and etiology. Pain 2001;93:247–257.
12. Jon Raphael, MB et al Cancer Pain: Part 2: Physical, Interventional and Complimentary Therapies; Management in the Community; Acute, Treatment-Related and Complex Cancer Pain: A Perspective from the British Pain Society Endorsed by the UK Association of Palliative Medicine and the Royal College of General Practitioners., Pain Medicine 2010; 11: 872–896.